

TEMA 4.12 • DERMATOLOGÍA

Dermatitis de Contacto

PERFIL EUNACOM 6.01.1.004

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Dermatitis de Contacto

Conforma una reacción de dermatitis (o eccema) inflamatoria provocada por el traspaso a la matriz intracelular cutánea producto del impacto ambiental directo exterior frotado sobre las células basales. Acorde en el EUNACOM se escinde su diferencial patogénico etiológico en 2 bandos polarizados absolutos:

1. Dermatitis de Contacto Irritativa (Tóxica Primaria)

- **Fisiopatología Estructural Causal:** Consecuencias a nivel celular de abrasión química directa sin mediar factores inmune cruzados. Constituye el evento de que **Afecta Universalmente a "Cualquier" Persona que sea expuesta al Agente.** (Nadie reacciona fisiológicamente indiferente con resiliencia ante un charco corrosivo industrial o ácidos en la piel de sus manos; te caiga sea en ti, sea en el médico). - **El Agente Involucrado:** Factor químico hiper-irritante puro nocivo sin treguas de tipo alcalosis o puramente ácidos letales disolventes. - **Relación de Severidad Expansiva con Dosis Asignada:** Es directamente proporcional. Es decir, es obligadamente e inherentemente **Dosis Dependiente.** Si caen mil litros de ácido, te incinera brutal en placa inmensa versus una sola mísera microgota limitando una mancha pequeña perimetral superficial sin profundidad de cráter ni ardor extremo generalizado perimetral en la placa de impacto de la mano.

2. Dermatitis de Contacto Alérgica (Reacción Inmune Tardía Tipo IV)

- **Fisiopatología Estructural Causal:** Al revés que la tóxica primaria universal inmanejable; esta obedece únicamente cruzando y generando injuria masiva celular focal pura y dolorosamente de manera **Exclusiva en aquellos pacientes previamente ya Sensibilizados.** Y su letal daño general o leve radica y salpica en una patología que es de todo punto de vista **Absolutamente Dosis INDEPENDIENTE** a la cantidad del roce. (Basta rozarse o usar apenas una hora o gotita perimetral por ejemplo para alborotar inmensamente roja reventándose la matriz inmune total de brazo por completo diseminando desproporcional el cuadro exagerado que exuda líquido y sobrepasa por completo o asfixia en placas toda la zona expuesta limitada incontrolable paralela y lateral general perimetral). - **Los Agentes Alérgenos Típicos Culpables:** El agente infalible rey en su casuística cruzada femenina frecuente o metálica de collares de fantasía se centra en las aleaciones y aleantes del **Metal Níquel, el uso prolongado atópico cruzado con las pastillas perfumosas químicas de los Cosméticos faciales cosméticos/Maquillaje de polvos rudo, los agresivos Detergentes residuales pesados ropas y los asfixiantes Desodorantes antitranspirantes sintéticos cruzados.**

Fases Clínicas Manifestacionales

Ambas versiones inflamatorias crónicas o inmediatas oscilan clínicamente a través de tres estadios en profundidad crónica temporal: 1. **Fase Aguda (El estallido crudo activo rápido):** Destaca un agresivo estallido de eritema doloroso pruriginoso acompañado por estigmas acuosos y de edema de exudación fibrinoso activo, manifestándose a través de **Ampollas vesiculares diseminadas rotas y extensas Bulas.** 2. **Fase Subaguda (Meseta de Transición):**

Va reseccándose el tejido bulloso, bajando a manifestarse más bien sólo eritematosa sólida. 3. **Fase Crónica Residual (El roce tardío seco incontrolable perenne):** Su constante injuria e invasión celular cicatricial hace que la piel se defiende volviéndose hipertrofiada agrietada seca en su perimetral: **Se origina una extensa y corácea Liquenificación por inflamación profunda y un cráter de Descamación con alteraciones postinflamatorias pigmentarias discrómicas locales residuales.**

Protocolo Terapéutico

- **Medida Principal Central N°1 Basal de Oro Innegociable EUNACOM:** El cese primario se basa universalmente **Cese y Prohibición permanente "EVITAR ABSOLUTAMENTE EL CONTACTANTE Gatillantr / Alérgeno".** - **Manejo Diagnóstico confirmatorio e Inmunológico de Investigación secundaria en Consultorio Especialista (En caso alergia dudosa e ignorada residual incontrolable):** Requerimiento EUNACOM se le indica solicitar sin dudas de despiste diagnóstico aplicar un panel de alérgenos por parches dérmicos controlando de rechazo a días (**Test de Parche Cutáneo Sensibilizador "Patch Test" Típico en espalda cruzado basal**). - Tratamiento y Apaciguamiento de Rescate Agudo en placas: Supresora estandar por ungüentos o lociones de un choque leve basical general Tópico basado prioritariamente de **Corticoides tópicos directos desinflamatorios agudos y el acompañarlo oral sintomático de alivio de los Anti-histamínicos en píldoras (Por el altísimo Prurito basal exacerbado de los pacientes en sus zonas de pliegues en su cuadro alérgico constante).**

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"¿Qué diferencia fundamentalmente la dermatitis de contacto alérgica de la irritativa?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Dermatitis de Contacto. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La dermatitis de contacto alérgica es hipersensibilidad tipo cuatro que requiere sensibilización previa.
- La dermatitis alérgica no es dosis-dependiente y las lesiones pueden extenderse fuera de la zona de contacto.
- La dermatitis de contacto irritativa es una reacción tóxica directa que afecta a cualquier persona.
- La dermatitis irritativa es dosis-dependiente y las lesiones se limitan estrictamente a la zona de contacto.
- El test de parches o prueba epicutánea permite identificar el alérgeno causante.
- El níquel, el caucho y los cosméticos son los alérgenos más frecuentes de dermatitis alérgica.
- El tratamiento principal es eliminar el contactante más corticoides tópicos para la inflamación.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (DERMATITIS DE CONTACTO)**PREGUNTA 1**

¿Qué diferencia fundamentalmente la dermatitis de contacto alérgica de la irritativa?

- A)** La alérgica se limita a la zona de contacto y la irritativa se puede extender
- B)** La alérgica requiere sensibilización previa y no es dosis-dependiente, la irritativa no
- C)** La alérgica solo afecta manos y la irritativa puede afectar cualquier zona del cuerpo
- D)** La alérgica se trata con antibióticos y la irritativa se trata con corticoides tópicos
- E)** La alérgica es más frecuente que la irritativa en la población general

PREGUNTA 2

¿Qué prueba diagnóstica permite identificar el alérgeno en la dermatitis de contacto alérgica?

- A)** La prueba de prick test con extractos alérgenos estandarizados intradérmicos
- B)** El test de parches o prueba epicutánea con los posibles alérgenos en la espalda
- C)** La biopsia de piel con inmunofluorescencia directa para detectar el anticuerpo
- D)** La determinación de IgE específica en sangre frente a los posibles alérgenos
- E)** La resonancia magnética de piel para identificar el patrón de inflamación dérmica

PREGUNTA 3

¿Cuáles son los alérgenos más frecuentes en la dermatitis de contacto alérgica?

- A)** Pólenes, ácaros del polvo y epitelios de animales domésticos
- B)** Metales como el níquel, caucho, cosméticos y plantas como el litre
- C)** Alimentos como los mariscos, el huevo, la leche y el trigo
- D)** Fármacos tópicos como los antibióticos, antifúngicos y corticoides
- E)** Bacterias como el estafilococo áureo y el estreptococo beta hemolítico

RESUMEN: DERMATITIS DE CONTACTO

La dermatitis de contacto es una reacción inflamatoria de la piel producida por el contacto con una sustancia externa. Tiene dos formas principales con mecanismos muy distintos. La dermatitis de contacto alérgica es una reacción de hipersensibilidad tipo cuatro mediada por linfocitos T, requiere sensibilización previa con al menos un contacto anterior, no es dosis-dependiente por lo que pequeñas cantidades pueden desencadenar la reacción, y las lesiones pueden extenderse más allá de la zona de contacto. Los alérgenos más frecuentes son los metales como el níquel, el caucho, los cosméticos y las plantas. La dermatitis de contacto irritativa es una reacción directa y tóxica al contactante, no requiere sensibilización previa, es dosis-dependiente, afecta a cualquier persona en contacto con suficiente cantidad, y las lesiones se limitan estrictamente a la zona de contacto. El diagnóstico diferencial se establece con el test de parches o prueba epicutánea. El tratamiento de ambas formas incluye identificar y evitar el contactante, más corticoides tópicos para la inflamación activa.